

ICUせん妄に患者と家族はどう対処しているか — 10質的研究のメタ統合、家族が最大の対処資源(MMSR・CritCare2026)

出典	Oh E, Marx-Rosenberg G, Schimböck F, Groth N, Nydahl P, Gallinat J. Psychosocial coping with intensive care delirium: a mixed-methods systematic review of patient and family perspectives. Critical Care. 2026;30:440. DOI: 10.1186/s13054-026-06232-1
掲載誌	Critical Care(2026)
原著	doi.org/10.1186/s13054-026-06232-1 (本文PDFは別途)
原題	Psychosocial coping with intensive care delirium: a mixed-methods systematic review of patient and family perspectives



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み この論文は「せん妄をどう減らすか」ではなく「せん妄の最中に患者と家族が何をしているか」を扱う。当院の Hotel ICU と ICU意思決定支援・倫理の両方に直撃する。

1. 家族を「面会者」から「対処資源(coping agent)」に位置づけ直す この統合の最大の主張は、家族が患者にとって最も一貫して効いていた対処資源だったという点。当院はすでに柔軟な面会に舵を切っているが、面会の位置づけがまだ「家族の権利」「家族の満足度」に寄っている。この論文を根拠に、面会を **せん妄ケアの介入(ABCDEF バンドルの F)** として再定義できる。具体的には、面会時に家族へ渡す1枚のカードで「今日していただきたい3つ」を提示する形にする(下の「家族への3つのお願い」)。

2. 「家族への3つのお願い」カードを作る(今すぐ作れる・費用ゼロ) 統合で最も証拠密度が高かった家族の行動を、そのまま3項目に落とす。

- **そばにいて、手に触れて、落ち着いた声で話してください**(emotional presence／10本中半数超で報告・家族の对患者戦略で最強の証拠)
- **今日の日付・場所・今起きていることを、繰り返し伝えてください**(active reorientation。訂正・議論はしない)
- **家から見慣れたものを持ってきてください**(本・カレンダー・枕・写真・十字架など。安心感と時間感覚の回復)

「訂正しない・否定しない・議論しない」を明記する(Bohart らの「accepting rather than correcting」)。**家族は指示がないと「違うよ、ここは病院だよ」と否定してしまう**ため、この一文の有無で家族の行動は変わる。

3. 患者側の「小さな自律」を意図的に作る Menza らの音楽研究がこの統合の中でも特に鮮やかで、患者は自分で曲を選ぶ・モニター音やドアの音を調整してもらうといった **わずかな選択権** を通じて主体性を取り戻していた。当院の音環境プロジェクト(ICUの大きな音は患者の耳のすぐ横から出ている — 4床室・248日・1225万点の音源位置マッピング(Anaesthesia2019)、ICUの騒音は数十年変わっていない — 平均55~60 dBA・ピーク85~90 dBA、単発介入は続かない(ナラティブレビュー・CritCareResPract2026))と直結する。騒音低減を「dB を下げる工学課題」だけでなく「**患者が音を選べるようにする自律の課題**」として設計し直すと、実装のハードルが下がり効果の説明もつく。

- 具体案: ベッドサイドに患者本人(または家族)が選んだプレイリストを流せる小型スピーカーを常設し、患者が「止めて／かけて」と言える状態を作る。当院はすでに **音楽療法の重症患者への効果**(鎮

静・鎮痛・せん妄)SR (CritCare2019)・ICUでの生演奏は「日常からの休息」になる — 非鎮静患者18名の質的研究・5テーマ (IJQSHW2024) を持っており、根拠の積み増しになる。

- モニターアラームの閾値見直しは「患者の自律」の名目で通したほうが、安全部門との議論が噛み合う。

4. せん妄の説明を「家族への説明」から「患者本人への説明」に広げる 患者側で最も一貫していた対処は **active sense-making (自分に何が起きているのかを理解しようとする)** だった。ところが当院を含め、せん妄の説明はほぼ家族向けに行われている。回復期の患者本人に対して「あなたが見たものはせん妄という状態で起きたもので、精神の病気ではない」と伝える定型の一言を、ICU退室時サマリーの説明項目に入れる。Granberg らの「自分は気が狂ったのだと思って症状を否認した」という記述は、**説明されないことが患者を苦しめている**ことを示している。

5. ICU日記の位置づけを再考する 著者らは sense-making 支援として ICU日記を挙げているが、当院の既存整理では ICUダイアリーは3か月後のPTSD症状を減らさない(多施設RCT 657例・JAMA2019) があり、PTSD 予防としては否定的。この論文と合わせると、**ICU日記は「PTSD を減らす薬」ではなく「患者の sense-making を助ける道具」として評価軸を変えるべき**という読み方になる。当院で導入するなら、アウトカムを PTSD 発症率ではなく「退室後に自分の体験を説明できるか」に置く。JC ではここが最も議論になる論点。

6. 家族自身の心理支援を、面会支援とセットで組む 家族は患者を支えながら、同時に自分の苦痛を情報探索・回避・肯定的再評価で処理していた。情報がないと「受動的な信頼」に退行する (Huang らの台湾コホート)。逆に言えば **情報提供は家族の対処能力そのものを底上げする介入** になる。ただし当院は ICUの家族支援介入は満足度を上げてPICS-Fは減らせない — 16施設885家族を1年追跡し全アウトカムで有意差なし (FICUSクラスターRCT・ICM2026) と 多職種による家族支援介入は家族の心理症状を改善しないがコミュニケーションの質を上げICU滞在を短縮する (PARTNER 段階的ウェッジRCT・NEJM2018) を既に持っており、**「家族支援介入は満足度とコミュニケーションの質は上げるが、家族の心理症状は減らせない」という厳しい現実**を踏まえる必要がある。本論文が示すのは「介入パッケージを足す」方向ではなく、**家族が既にやっている行動を邪魔しない・言語化して後押しする** という方向。この差がJC での実務的な落とし所。

7. せん妄評価に家族を巻き込む流れと接続する 当院は 家族にせん妄評価をせよと家族の満足度が上がる — 言語障壁がある家族ほど効果大きい(前向きコホート・ICM2026) を検討済み。本論文はその「なぜ効くのか」の説明を与える — 家族にとって評価への参加は問題焦点型コーピング (collaboration with HCP) そのもので、受動的な待機を能動的な関与に変える。せん妄評価への家族参加は、患者のためだけでなく **家族自身の PICS-F 予防** として提案できる。

8. 文化的コーピングを「非科学的」と切り捨てない 台湾の研究では祈り・占い・漢方が家族の対処として報告され、著者らは Lazarus & Folkman モデルの外側にあると明記した。当院は外国人患者・家族が多く、**宗教的・文化的な対処行動をスタッフが黙認ではなく積極的に支持することが、家族の対処資**

源を守ることになる。チャプレンサービスとの連携(当院の強み)を、せん妄ケアの文脈でも明示的に使う。

変わらないもの: 薬物療法の方針は一切変わらない。この論文はせん妄の予防・治療の有効性を何も検証していない(質的研究のみ・定量的エビデンスはゼロ)。ハロペリドール・デクスメトミジンの位置づけは既存ノートのまま。

この論文の位置づけ(Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known:** ICUせん妄は成人ICUで発生率31~80%、COVID-19期の14か国多施設コホートでは有病率54.9%。認知機能・死亡・機能予後・QOL・長期施設入所に負の影響を与える。患者は恐怖・怒り・恥・無力感を訴え、幻覚と失見当識を伴い、退院後もうつ・不安・PTSD・認知障害が残る。家族もまた不安・うつ・PTSD を負う。患者と家族は「せん妄で最も対処すべきアウトカム」として **情緒的苦痛** を100項目中1位に挙げている。
- **Unknown:** これらの苦痛に対して、患者と家族が **実際に何をしているのか(=コーピング)** は系統的に調べられていなかった。既存の質的研究はもっぱら「どれだけ辛かったか(ストレスター)」を記述するにとどまり、能動的な対処プロセスの統合はなかった。
- **What's new:** Lazarus と Folkman の**ストレス・コーピングの相互作用モデル**を分析枠組みに据え、患者と家族の**双方向(bilateral)**の視点からコーピングを統合した初めての系統的レビュー。7か国・10本の質的研究(1999~2025年)を JBI メタアグリゲーションで統合した。同時に、**適格基準を満たす定量研究が1本も存在しなかった**ことを「レビュー過程の所見」として報告している。患者は認知機能が障害されているにもかかわらず、問題焦点型・情動焦点型に加えて **意味基盤型コーピング(肯定的再評価・アイデンティティの回復)** まで示していた。

全体要約

要旨

ひとことで ICUせん妄の渦中にあっても、患者は意味づけと人とのつながりで能動的に対処しており、家族は患者を支える最大の対処資源であると同時に自分自身の苦痛も抱えている。**せん妄ケアの設計は「患者と家族を受け身の被害者ではなく能動的な対処主体として扱う」方向へ転換すべきだ、というのが本レビューの核心的主張。**

- 4データベース (MEDLINE/PubMed、CINAHL、PsycINFO、PSYINDEX) で1,985件を同定、重複129件を除いて1,856件を抄録スクリーニング、最終的に**10本の質的研究**を採用。**定量研究は1本も適格でなかった。**
- 対象研究は7か国 (中国3、スウェーデン・カナダ・英国・デンマーク・台湾 各1、米国2)、発表年1999～2025年、参加者数は6～77名。
- 方法論的質は良好で、MMAT 5基準をすべて満たしたのが **8/10(80%)**、1基準が「判断不能 (Can't tell)」だったのが **2/10(20%)**。「No」判定はゼロ。
- **患者のコーピング**は3型すべてに及んだ。問題焦点型＝能動的な意味づけ・現実見当識の確認・せん妄誘因の先制的回避。情動焦点型＝社会的つながり・距離を取ること・自己制御。意味基盤型＝肯定的再評価・アイデンティティの回復。最も一貫して報告されたのは **能動的な意味づけ(4研究)と社会的つながり**。
- **家族のコーピング**は2方向に分かれる。①患者に向けたもの＝情緒的な存在(そばにいる・手を握る)、能動的な再見当識づけ、認知的刺激、医療チームとの協働。②自分の苦痛を管理するもの＝情報探索、回避、肯定的再評価。
- 对患者では **情緒的な存在と関係的サポート**が最も一貫(10本中半数超)。自己の苦痛管理では **情報探索と回避**が二大戦略。
- 適応的コーピングには境界がある。情報が不足すると能動的関与が **受動的な信頼**にすり替わり、負担が過大になると回避と自己防衛に転じ、過剰な介護役割を引き受けた家族は情緒的疲弊のリスクを負っていた。
- 著者らは相互作用モデル自体の限界も明示した。せん妄による認知障害下では、モデルが想定する「熟慮的な評価 (appraisal)」が成り立たない可能性があり、患者のコーピングは **反動的・意識閾下に立ち現れるの**かもしれない。占い・伝統医療といった文化的コーピングはモデルの射程外。

詳細

1. まず前提 — この病態・理論の基礎(初めての人にも)

要旨

5分で背景を掴む **せん妄(delirium)** は意識と注意の状態が急性に変動する器質性脳症候群。成人ICUでの発生率は31～80%と幅広く報告され、COVID-19 期の14か国多施設コホートでは有病率54.9%だった。高齢者が不均衡に脆弱なため、人口高齢化に伴って臨床的負担は増大すると予想される。

コーピング(coping) は「ストレスと評価された、あるいは自分の資源を超えると評価された要求を処理するための、能動的な認知的・行動的努力」。Lazarus と Folkman の **相互作用モデル(transactional model of stress and coping)** では、人と環境の相互作用がストレスを生み、それが継続的な評価(appraisal)と再評価(reappraisal)を通じて処理され则认为。コーピングは3つに分類される。

型	何に向かうか	ICUせん妄での例
問題焦点型 (problem-focused)	ストレスの源そのものを操作する	周囲の手がかりを探して現在地を理解する／鎮静薬を拒否してせん妄の再燃を避ける／家族が医療者に情報を求める
情動焦点型 (emotion-focused)	情動反応を調節する	家族や看護師とのつながりに安心を得る／機械音から気をそらす／恐怖を内的対話で抑える
意味基盤型 (meaning-based)	持続するストレス下で意味を再構成する	肯定的再評価、希望、アイデンティティの回復、スピリチュアルな信念

意味基盤型は Folkman が1997年に拡張した層で、**一次的なコーピングでは足りない長期のストレス下で立ち現れる**とされる。

一次評価(primary appraisal) はその出来事が脅威か・挑戦か・害かの判断、**二次評価(secondary appraisal)** は自分にどんな対処資源があるかの判断を指す。本レビューで社会的つながりが繰り返し登場するのは、二次評価における対人関係資源の中心性を反映している。

本レビューで登場する方法論の用語

- **MMSR(mixed-methods systematic review)**: 定量研究と質的研究の双方を統合する系統的レビュー。本研究は JBI(Joanna Briggs Institute)の方法論に従った。
- **収束統合アプローチ(convergent integrated approach)**: 定量データを質的な記述に変換(qualitised)した上で質的知見と一体的に統合する JBI の手法。本研究では定量研究が1本もなか

ったため、実質的に質的統合のみとなった。

- **メタアグリゲーション(meta-aggregation)**: 質的知見を①知見の抽出と信頼性評価 ②記述的カテゴリへの分類 ③統合知見への集約、の3段階で束ねる JBI の手法。理論を新しく生成する(メタエスノグラフィー)のではなく、実践に使える形に集約するのが目的。
- **MMAT(Mixed-Methods Appraisal Tool)**: デザイン別に5つの基準で研究の質を評価する道具。合計点は出さない設計になっている。
- **PICS / PICS-F**: 集中治療後症候群(患者／家族)。本レビューの含意はこの下流に直結する。

2. 背景と目的

ICU入室は患者にとっても家族(パートナー・親・子・近しい介護者・患者のケアに情緒的に関与する重要他者)にとっても深刻なストレスとなる。Schmitt ら(2019)は患者・家族介護者・看護スタッフに共通する3つの負担次元 — **症状負担・情緒的負担・状況的負担** — を同定し、せん妄はしばしばこれらを伴うと示した。せん妄をひとつの集団だけが単独で経験することはない、という認識が本レビューの出発点にある。

患者は恐怖・怒り・恥・無力感といった強い情動症状と、幻覚・失見当識といった認知障害を訴える。急性期を越えても、ICUせん妄はうつ・不安・PTSD・認知障害という長期的な心理的後遺症と関連し、生存者の健康関連QOLを大きく損なう。

家族介護者も複数の心理社会的ストレスに直面する。医療の理解の困難さ、医療者とのコミュニケーション障壁、罪責感・悲嘆・情緒的麻痺を伴う圧倒的な情動反応。せん妄状態の家族を目の当たりにすること自体が不安・うつ・PTSD と関連する。

決定的な背景として、患者と家族は **情緒的苦痛をせん妄研究で取り組むべき最重要アウトカムとして100の候補の中で1位に挙げている**。にもかかわらず、その苦痛にどう対処しているかは系統的に調べられてこなかった。

目的(原文): ICUせん妄に対して患者と家族介護者が用いる心理社会的コーピング戦略のエビデンスを、相互作用モデルの枠組みの中で同定・統合・批判的吟味すること。問題焦点型・情動焦点型・意味基盤型の戦略を双方の視点から同定し、両者の間の関係的プロセスを探索することを狙いとした。

3. 方法(Methods)

- **デザイン**: JBI の方法論に従った混合研究法系統的レビュー(MMSR)。PRISMA 2020 に準拠して報告。2025年にレビュープロセスを開始し、PROSPERO に前向き登録(CRD420251186487)。
- **適格基準(組み入れ)**

- **Population:** ICU滞在中にせん妄を経験した、あるいは経験したと報告された成人患者(18歳以上)、および／またはその家族介護者(パートナー・親・子・近い家族介護者、選択的家族構成を含む重要他者)。
- **Intervention(定量部分):** ICUせん妄へのコーピングを標的とした心理社会的介入。「せん妄エピソード中の患者または家族の適応的コーピング反応を促進することを明示的に目的とした、構造化された心理的・社会的・支持的介入」と操作的に定義。
- **Phenomena of Interest(質的部分):** ICUせん妄に対する心理社会的コーピング戦略。問題焦点型・情動焦点型・意味基盤型・スピリチュアル・社会的コーピング、レジリエンス、適応、心理的回復を含む。
- **Outcomes(定量部分):** コーピング・レジリエンス・心理的回復の実証的測定。
- **Context:** ICU、CCU、ITU、Critical Care。ICU滞在中の研究でも、ICUせん妄体験の後方視的な語りをを用いた研究でも可。
- **Time frame:** 2025年11月6日までの出版物。**言語制限なし。**
- 質的・定量的・混合研究法のいずれも、ICU滞在中・ICU退室後・集中治療後回復期のいずれで実施されたものも、せん妄エピソードとの明確な連関があれば対象とした。
- **適格基準(除外):** 成人ICU以外の文脈(小児・新生児・緩和ケア)、患者のせん妄体験と直接の連関がない介護者・医療者を中心とした研究、せん妄予防のみ・純粋に薬理学的／生理学的管理のみを扱う研究(明確な心理社会的コーピングの焦点がない限り)、神経生物学的機序や認知機能単独を扱う論文、非実証的な出版物(レビュー・メタ解析・プロトコル・論評・純理論的議論)、全文のない学会抄録・症例集積・灰色文献(学位論文・学会論文)。
- **検索戦略:** MEDLINE(PubMed)、CINAHL、PsycINFO、PSYINDEX の4データベース。主要検索語は'delirium'、'intensive care'、'coping'、'family'。**期間制限なし。**検索完了は2025年11月6日。一次データ収集なし。
- **選択プロセス:** Rayyan で管理。重複除去後、2名(E.O.、F.S.)が2025年11月～12月に独立して抄録スクリーニング。少なくとも1名が関連ありと判断した記録は全文を取得。**全文スクリーニングでは評価した33件のうち8件(24%)で不一致が生じ、すべて2名の合意討議で解決した。**
- **質評価:** 2名(E.O.、N.G.)が2025年12月～2026年3月に MMAT(2018年版)で独立評価。デザイン別5基準。MMAT は総合スコアや順位づけを推奨していないが、本レビューでは叙述の便宜上、「No」または「Can't tell」が1つ以下の研究を **higher-quality**、2～3つの研究を **moderate-quality** と呼んだ。著者らはこの分類を「研究の頑健性を過大評価しないよう慎重に解釈すべき」と自ら留保している。不一致は相互対話で解決し、著者への外部照会や第3のレビュアーは不要だった。
- **データ抽出:** 2名(E.O.、N.G.)が2025年12月～2026年3月に、レビューチームが開発した抽出フォームで独立実施。抽出項目は著者・年・国・研究デザイン・セッティング・サンプルサイズを含む参加者特性・報告アウトカム・患者と家族双方の視点から同定されたコーピング戦略。

- **統合:** JBI 収束統合アプローチ。検索は定量・質的双方を捉える設計だったが、スクリーニング後に適格な定量研究は1本も同定されなかったため、統合は質的エビデンスのみで実施された。**MMSR の枠組みは維持された。探索に先立って MMSR として前向き登録されていたため、定量エビデンスの不在は「デザインの事後変更」ではなく「レビュー過程の所見」であるというのが著者らの立場。**
- 質的知見は JBI メタアグリゲーション3段階 (①知見の抽出と信頼性評価 ②記述的カテゴリへの分類 ③カテゴリの統合知見への集約) で分析。
- カテゴリ化は**演繹的・帰納的の併用**。まず相互作用モデルに沿って整理し、枠組みを越えて立ち現れたカテゴリは帰納的に取り込んだ。最終段階で全統合知見を包括的統合に集約し、同定されたコーピング戦略を参加者の体験と文脈要因に結びつけた。

4. 研究選択の流れ (PRISMA)

図の解説

Figure 1. 研究選択プロセスの PRISMA フロー図。図は縦一列の流れで、左端に「Identification」「Screening」「Included」の3段階が水色の縦帯で示され、各段階の右側に白いボックスが並び、除外された記録が右向き矢印で右列のボックスへ抜けていく構成。最上段の濃紺の帯に「Identification of studies via databases and registers」。

①データベースから同定 $n=1,985$ (内訳: PubMed $n=1,498$ / CINAHL $n=161$ / PsycINFO $n=323$ / PSYINDEX $n=3$) → 右へ「スクリーニング前に除外: 重複 $n=129$ 」。

②スクリーニングされた記録 $n=1,856$ → 右へ「除外 $n=1,819$ 」。

③全文取得を試みた報告 $n=37$ → 右へ「取得できず $n=4$ 」。

④適格性を評価した報告 $n=33$ → 右へ「除外: 対象集団が不適 $n=5$ / 介入が不適 $n=2$ / アウトカムが不適 $n=16$ 」。

⑤レビューに採用された研究 $n=10$ 。

数値の整合はすべて取れている ($1,498+161+323+3=1,985$ / $1,856-1,819=37$ / $33-23=10$)。

5. 採用研究の特性

10本すべてが質的研究で、1999年から2025年にかけて発表され、7か国から集まった。中国が3本と最多で、スウェーデン・カナダ・英国・デンマーク・台湾が各1本、米国が2本。

対象集団の内訳は、患者と家族介護者の**双方**を含む研究が5本、家族介護者のみが3本、患者のみが2本。サンプルサイズは6～77名。すべて成人ICUで、大半が術後ICUまたは内科系ICUの文脈。

Table 1. 採用された10研究の特性 (原表を日本語化)

著者・年(国)	質的デザイン	ICUの種類／対象	データ収集と分析法	コーピングの位置づけと文脈
Granberg ら, 1999(スウェーデン)	解釈学的現象学	一般ICU／人工呼吸患者	半構造化面接 n=19、解釈学的テキスト分析 (Malterud)	二次的・偶発的所見／ICU後の回復期
Whitehorne ら, 2015(カナダ)	解釈学的現象学(van Manen)	内科・外科ICU／CAM-ICU陽性患者	半構造化面接 n=10、ICU転出後、van Manen 主題分析	二次的・偶発的所見／ICU後の回復期
Darbyshire ら, 2016(英国)	質的二次解析／主題分析	混合ICU／一般ICU患者	アーカイブ面接の二次解析、患者 n=40・家族 n=37、主題分析 (恒常比較法)	二次的・偶発的所見／ICU後の回復期(後方視)
Smithburger ら, 2017(米)	グラウンデッド・セオリー	大学病院の内科ICU／せん妄患者	電話面接 n=10、グラウンデッド・セ	二次的・偶発的所見／ICU滞在中の家族介護

著者・年(国)	質的デザイン	ICUの種類／対象	データ収集と分析法	コーピングの位置づけと文脈
国)		者の家族	オリ－・コーディング(NVivo)	
Bohart ら, 2019(デンマーク)	現象学 (Malterud STC)	一般内科・外科 レベルII ICU／ CAM-ICU陽性 患者の家族	半構造化面接 n=11、ICU入室 中～直後、系統的 テキスト凝縮 (Malterud)	二次的・偶発的所見／ICU 滞在中の家族介護
Huang ら, 2022(台湾)	記述的質的 研究	北部台湾の医療 センター成人 ICU／せん妄患 者の家族介護者	対面半構造化面接 n=20(各約1時 間)、質的内容分析	二次的・偶発的所見／家族 介護。ICU退室との時間関 係は明記なし
Ma ら, 2024 (中国)	記述的質的 研究	三次病院の step-down	対面面接 n=17 (患者6・家族11、 6ダイアド+5個	二次的・偶発的所見／ICU 転出後、入院継続中に面接

著者・年(国)	質的デザイン	ICUの種類／対象	データ収集と分析法	コーディングの位置づけと文脈
		unit／ICU後せん妄患者と家族	別)、帰納的主題分析(Braun & Clarke)、NVivo 11 Plus	
Menza ら, 2024(米国)	グラウンデッド・セオリー (Charmaz)	都市部大学病院のレベル1外傷センター、外傷・脳神経ICU／患者・家族・友人	半構造化面接 14 面接／21情報提供者、グラウンデッド・セオリー (Charmaz)、オープンコーディング、恒常比較 (Atlas.ti 9.1)	二次的・単一コードのみ (名づけられたテーマではない)／主にICU・入院中、1面接のみ入室7か月後
Dong ら, 2025(中国)	質的記述研究(自然主義的探究)	三次病院の混合ICU 3床群／術後せん妄患者と家族	ダイアド半構造化面接、患者・家族ペア18組＋家族2名、ICU退室後1週間以内、主題分析 (Braun & Clarke)、NVivo 12	二次的・偶発的所見／ICU退室後、転出後1週間以内

著者・年(国)	質的設計	ICUの種類／対象	データ収集と分析法	コーピングの位置づけと文脈
Zhang ら, 2025(中国)	解釈的現象 学的分析 (IPA)	三次病院の15床 ICU／高齢術後 患者(65歳以 上)と家族	半構造化個別面 接、患者・家族ダイ アド8組、ICU退室 1か月後、30～45 分、IPA(NVivo 15)	一次的・明示的に名づけら れたテーマ("Finding Ways to Cope")。ただし 理論的に事前規定されては いない／ICU退室後1か月

この表から読み取るべき最重要点: 10本中9本で、コーピングは **研究の一次アウトカムではなく偶発的に浮かび上がった所見** だった。コーピングを明示的なテーマ("Finding Ways to Cope")として扱ったのは Zhang ら(2025) 1本のみで、それすら事前の理論枠組みを持たない。この事実は本レビュー最大の弱点であり、著者らも限界として自ら明記している。

6. 方法論的質の評価(MMAT)

採用10研究の全体的な方法論的質は高かった。5基準すべてを満たした **higher-quality が 8/10 (80%)**、1基準が「Can't tell」だった研究が **2/10(20%)**。「No」判定はひとつもなかった。

質的設計の適切性(Q1)はすべての研究で妥当と評価された。知見はデータに明確に基づき、データによって裏づけられた一貫した分析と解釈が提供されていた。

- **Darbyshire ら(2016)**: Q2(データ収集法の妥当性)が Can't tell。手順が十分明確に記述されていなかったため。
- **Smithburger ら(2017)**: Q3(知見の導出)が Can't tell。生データと報告された結果の連関が完全には透明でなかったため。

Table 2. MMAT による批判的吟味の結果(原表を日本語化)

著者・年	Q1 質的アプローチは問いに適切か	Q2 データ収集法は妥当か	Q3 知見はデータから適切に導かれたか
Granberg ら, 1999	Y	Y	Y
Whitehorne ら, 2015	Y	Y	Y
Darbyshire ら, 2016	Y	CT	Y
Smithburger ら, 2017	Y	Y	CT
Bohart ら, 2019	Y	Y	Y
Huang ら, 2022	Y	Y	Y
Ma ら, 2024	Y	Y	Y
Menza ら, 2024	Y	Y	Y
Dong ら, 2025	Y	Y	Y
Zhang ら, 2025	Y	Y	Y

Y＝基準を満たす、CT＝判断不能（情報が不明確または不十分）、N＝満たさない。MMAT 2018年版を用い2名（E.O.、N.G.）が独立評価。MMAT の指針に従い数値スコア化はせず、叙述目的で高・中・低に分類した。

7. 統合結果 その1 — 患者の視点

患者側では、Lazarus と Folkman の3分類に沿って広範なコーピング戦略が同定された。

7-1. 問題焦点型 — 能動的な意味づけと現実見当識(最も顕著な急性期戦略)

最も一般的だったのは **能動的な意味づけ (active sense-making)** と **現実見当識 (reality orientation)** だった。

- 患者は環境の中に手がかりを探し、何が起きているのか、自分がどこにいるのかを理解しようとした (Whitehorne、Menza)。
- 状況について **物語を作る**ことは、現実の理解を得ようとする意図的な試みだった (Darbyshire)。
- 非現実的体験に説明をつけようとすることは、認知的な統御 (cognitive mastery) の手段だった (Granberg)。

この戦略は採用10研究のうち**4研究**で同定され、患者の急性期における最も顕著な問題焦点型パターンと位置づけられた。

7-2. 問題焦点型 — 統制と自律の回復、先制的回避

ICU入院中の患者の役割は大きく制約されているにもかかわらず、一部の患者は能動的に統制を取り戻そうとした。

- **自分で音楽を選んで流す**、あるいは邪魔になるモニターやドアの突然の音を**加減してもらう** (Menza)。
- せん妄エピソードの再燃を誘発しかねない場面を能動的に拒否する — **睡眠薬や鎮静を断る** (Whitehorne)。

7-3. 情動焦点型 — 社会的つながり (最も一貫して報告された資源)

意味づけの努力に続いて、**社会的つながりを求める**ことが複数の研究で一貫して示された。

- 患者は家族介護者に支えを求め、家族の存在は慰めと生き延びる力を与えた (Dong、Granberg)。
- 優しい言葉や身体的接触を通じて**ケアされていると感じる**ことが家族との情緒的絆になった (Whitehorne)。
- せん妄について家族と語り合うことが、症状と状況を意味づける助けになった (Dong)。
- スタッフとつながることは安全感と現実との接触を改善した (Whitehorne)。

情動焦点型の資源の中で、社会的つながりは最も一貫して報告されたアプローチとして立ち現れ、二次評価プロセスにおける対人関係の中心的役割を反映していた。

7-4. 情動焦点型 — 距離を取る・回避

- 一部の患者は「自分は気が狂ってしまう」と信じたため、**せん妄症状を否認した** (Granberg)。
- ICUの機械音から自分の気をそらす、あるいは不安・呼吸困難・苛立ちといった問題から心を離す (Menza)。

- ある患者は夢から逃れるために能動的に眠らないようにした(Darbyshire)。

7-5. 情動焦点型 — 自己制御

- 恐怖の感情を管理するため、自らの情動を処理し侵入思考を制御しようとした(Menza)。時に**内的対話**を保つことによって(Granberg)。
- ケア提供者への信頼と確信を持つこと、あるいは**馴染みの物を持っている**ことも安全感を与え、せん妄を伴うICU滞在中のレジリエンスへの通路になった(Granberg、Whitehorne)。

7-6. 意味基盤型 — 肯定的再評価とアイデンティティの回復

- **快い場所や状況への心的移動**を試み、恐ろしい状況の中で希望と生存の確信を励ました(Granberg)。
- **馴染みの音楽**は、個人や家族のアイデンティティと合致するとき、自分自身に引き戻される感覚をもたらした。意識の回復を支え、希望と喜びの体験を助けた(Menza)。
- **スピリチュアルな信念と実践**が患者を自らの信念体系に結びつけ、目的意識を回復させた(Menza、1研究)。

著者らはこれらを、Folkman(1997)が重篤で持続的なストレス下でも肯定的な心理状態を維持する適応的プロセスとして概念化した肯定的再評価・スピリチュアルな信念と一致すると位置づけた。

患者の統合結論: 患者のコーピングは問題焦点型・情動焦点型・意味基盤型のすべてに及び、**能動的な意味づけ**と**社会的つながり**が採用研究を通じて最も一貫して裏づけられたアプローチだった。

8. 統合結果 その2 — 家族の視点

家族介護者のコーピングは2方向に区別される。**A. 患者を支え援助するものと、B. 自分自身の苦痛を管理するもの。**

A-1. 情緒的な存在と関係的サポート(家族の对患者戦略で最強の証拠)

- 家族はベッドサイドにとどまり、患者と身体的接触を始めた(Smithburger)。
- 落ち着いた話しかけが個別的な励ましと動機づけを与え、「家族は元気だ」「経済的なことは心配しなくていい」というメッセージを伝えた(Ma、Bohart)。
- 病院の外の生活の記憶を呼び起こす会話内容が、患者にとって日常とのつながりの源になった(Menza)。
- 心理的ニーズに対応することで、患者の心理的負担の緩和を支えた(Ma)。
- 音楽に関連する記憶を通じて孤独を和らげたり、面会時間を離れるときにも安全感を与える馴染みの物を差し出した(Whitehorne、Menza)。

- 面会が制限されている時期には、前向きなメッセージが情緒的支援として機能し、患者の安心感と弛緩を高めた(Ma, Huang)。

この情動焦点型コーピングは **採用研究の半数超** で同定され、家族の対患者戦略の中で最も強いエビデンスを構成した。

A-2. 自己制御(情動焦点型)

- 家族介護者は慎重で、**自分の情緒的負荷を患者に転嫁することを避けた**。
- 患者のせん妄記憶を軽く扱うことと、患者の変化についての混乱を解きほぐすことの間でバランスを保った(Dong)。
- 自己調節の行為として、**些細なことは流す選択的関与**を試み、訂正するのではなく現実を受け入れた(Bohart)。

A-3. 能動的な再見当識づけと認知的刺激(対患者で2番目に高頻度・問題焦点型)

- さまざまな方法で現実見当識づけを提供しようとした(Ma)。
- 家から本・カレンダー・馴染みの物を持ち込み、**家庭的な馴染みやすさ**を作って患者の不安を軽減した。
- 時間・場所・状況を繰り返し説明してコミュニケーションと再見当識を助けた(Smithburger)。
- 一部の家族介護者は、やり取りを促す方法として**アイテムやチェックリスト**を提案した(Smithburger)。
- 音楽などの感覚刺激を通じて認知機能を維持し、記憶を呼び起こして覚醒を促した(Menza)。音楽は安全感の提供にも有用だった。
- 1研究では**ビデオ通話面会による家族の存在の延長**が患者の精神状態を改善し、せん妄治療へのアドヒアランスを支えたと報告された(Dong)。

著者らはここで重要な観察をしている。**これらの問題焦点型戦略は施設のガイドラインとして正式に定められたものではなく、家族介護者が自発的に始めたものだった**(Smithburger)。それが認知的再見当識にも社会的つながりにも寄与していた。

A-4. 医療チームとの協働(問題焦点型)

- 家族介護者は医療者との開かれたコミュニケーションと協働を能動的に始めた(Smithburger)。
- スタッフと患者の間の**コミュニケーション仲介者**として振る舞い、コミュニケーションの調整に努め、患者が医療スタッフを信頼し積極的に協力するよう促した(Dong, Ma)。
- 患者の状態を心配したとき、複数の視点から積極的に助けを求めた(Dong)。
- 患者ケアのための情報探索として、**せん妄の予防と管理に関する教育**を求めた(Smithburger)。

- 医療チームとの協働以外にも、他の家族から民間療法や中国の補完代替医療(CAM)の情報を得ることも報告された(Huang)。

A-5. アイデンティティの再構築(意味基盤型)

- 想起と再構築を助けることで、家族は患者の**かつての社会的役割を再建**しようとし、家族の日常や出来事を報告することで患者を外の世界とつないだ(Ma)。
- 血縁関係と、その人の人柄や好みについての固有の理解が患者を慰めた(Dong)。
- 病院の外の生活の記憶を呼び起こすことがアイデンティティ再構築に寄与した(Menza)。
- 音楽を流すことは患者を音楽に紐づいた記憶に引き戻し、意識の回復を助けた(Menza)。

A のまとめ: 情緒的な存在と関係的サポートが最も一貫して展開された戦略であり、能動的な再見当識づけとアイデンティティ再構築が、せん妄ケアにおける**能動的な対処主体としての家族の役割**を下支えしていた。

B-1. 情報探索と専門的支援(自己の苦痛管理で最頻の問題焦点型)

- 家族は状況をよりよく理解し管理するために、せん妄についてより多くの情報を求め、医療専門職との開かれたコミュニケーションが有益で安堵をもたらした(Smithburger、Bohart)。
- 1研究では、家族が**心理士と話すという専門的な心理支援**に手を伸ばしたことが報告された(Zhang)。

B-2. 回避と自己防衛(同じく高頻度の情動焦点型)

- せん妄とその治療についての情報が不足しているため、一部の家族介護者は**受動的に医療スタッフを信頼した**(Huang)。
- 自身の苦痛と気恥ずかしさを避けるため、せん妄の話題を回避した者もいた(Zhang)。
- 患者のせん妄記憶を軽く扱うことと患者の変化の混乱を解きほぐすことの間で慎重なバランスを保つことが、双方にとっての保護的戦略として記述された(Dong)。

B-3. 自己制御(情動焦点型)

- 家族は希望と安心を通じて自らのストレスを管理し、些細なことは流す選択的関与を実践した(Bohart)。

B-4. 正常化と肯定的再評価(意味基盤型・2研究)

- 不確実性の中でも希望的な展望を語り、**認知より生存を優先**することでせん妄体験を正常化した(Bohart)。
- 在宅回復への楽観が臨床状況へのコーピング反応として報告された(Zhang)。

B-5. スピリチュアル・文化的に埋め込まれたコーピング(1研究)

- 祈りや占いといった宗教的儀礼、および伝統中国医学の利用(Huang)。
- 著者らは「限られたエビデンスによる裏づけではあるが、ICUせん妄におけるコーピングプロセスの文化的特異性を示唆する」と慎重に述べている。

B のまとめ: 家族のコーピングは両方向で情動焦点型・問題焦点型・意味基盤型に及んだ。对患者では**情緒的な存在と関係のサポート**が最も一貫し、自己の心理的負担への対処では**情報探索と回避**が二大戦略だった。

9. 概念的統合図

図の解説

Figure 2. ICU患者と家族介護者のコーピング戦略の概念的統合図。改訂版の相互作用モデル上にマッピングされている。図は上から下へ流れる縦構造。最上部の灰色のボックスに「ICU delirium (ICUせん妄)」、下向き矢印で次のボックス「Appraisal (評価) — Threat・Challenge・Harm (脅威・挑戦・害)」、さらに下向き矢印で横長のボックス「Coping strategies (コーピング戦略)」。

その下に2つの大きな円が重なるベン図が配置され、左の青い円が「Patients (患者)」(副題は斜体で "Cognitive constraints / reactive・implicit" = 認知的制約下、反応的・意識閾下)、右の橙色の円が「Families (家族)」(副題は "Deliberate / goal-directed" = 熟慮的・目標志向的)。

左の円の中は3段構成で、Problem-focused = 意味づけ・現実見当識、自律と統制の回復、誘因の先制的回避 / Emotion-focused = ケア提供者への信頼、気そらし、距離を取ること、否認、睡眠の回避 / Meaning-based = 肯定的再評価、希望、スピリチュアルな信念。

右の円も3段で、上段の下線付き斜体見出し「Directed at patient (患者に向けて)」の下に Problem-focused = 再見当識づけ、認知的刺激、馴染みの物、情報探索、医療者との協働、情緒的な存在、身体的接触。下段の見出し「Managing own distress (自らの苦痛の管理)」の下に Problem-focused = 情報探索、正常化 / Emotion-focused = 回避、自己防衛 / Meaning-based = 肯定的再評価、スピリチュアル、文化的コーピング(この項目にはアスタリスクが付され、モデルの射程外であることを示す注記になっている)。

2円の重なり部分は「Shared (共有)」と表示され、Emotion-focused = 社会的つながり、存在、自己制御 / Meaning-based = アイデンティティの回復。

ベン図の下から下向き矢印が伸び、左に白いボックス「Potential adaptation (適応の可能性)」、右に濃い灰色のボックス「Potential distress (苦痛の可能性)」。

右のボックスからは破線の矢印が右端を上を回り込んで「Appraisal」のボックスへ戻り、持続する苦痛によって引き起こされる再評価(reappraisal)のループを表している。

矢印はコーピングプロセスの方向を示し、破線は再評価を意味する。Folkman (1997) から改変。HCP = 医療専門職、ICU = 集中治療室。

この図が伝える最も重要な構造は3つ。

図の要素	何を意味するか
患者の円に「反応的・意識闕下」、家族の円に「熟慮的・目標志向的」と対比的な注記がある	同じ「コーピング」でも、両者で成立の仕方が違うという著者らの理論的留保。せん妄下の患者は熟慮的評価ができない可能性がある
重なり部分に「社会的つながり・存在・自己制御・アイデンティティの回復」が置かれている	患者と家族が共有する対処資源はすべて「関係性」に由来する。 薬でも機械でもない
「苦痛の可能性」から破線で「評価」へ戻るループ	コーピングは一度で終わる直線ではなく、うまくいかなければ再評価が起きて別の戦略が立ち上がる循環。意味基盤型が後から立ち現れるのはこのループの帰結

10. 考察

10-1. 主要所見の位置づけ

本レビューは、10本の質的研究からICUせん妄に対する患者と家族介護者のコーピングを統合した。**体験に受動的にさらされるのではなく、患者も家族も能動的に広範なコーピング戦略を展開していた。**患者では能動的な意味づけと社会的つながり、家族では对患者の情緒的な存在・能動的な再見当識・医療チームとの協働、および自己の苦痛への情報探索・回避・肯定的再評価。

これらは Schmitt らの3つの負担パターン(症状負担・情緒的負担・状況的負担)と整合する。ICU昏睡患者の非公式介護者のコーピング研究(回避・気そらしという不適応パターンと、受容・意味づけという適応パターン)とも行動パターンが鏡像になっている。既存研究がストレスラーの多様性を記録したのに対し、本レビューは**それに対する能動的な対処戦略を双方向の視点から統合した点で一歩先へ進んでいる。**家族が主要な対処資源として振る舞い、患者はICU入室中の制約された役割にもかかわらず問題焦点型と情動焦点型を示し、両者は補完的な双方向コーピング反応を形成していた。

10-2. 適応的コーピングの境界(重要)

データは適応的コーピングの限界も示している。

状況	何が起きるか	臨床で見るべきサイン
家族が十分な情報を持たない	能動的関与が受動的な信頼に置き換わる (Huang)	「先生方にお任せします」以外の言葉が出てこない家族
心理的負担が圧倒的になる	回避と自己防衛に転じる (Zhang)	面会が減る、せん妄の話題を避ける、説明の場から離れる
過剰な介護役割を引き受ける	情緒的疲弊のリスク (Bohart)	常時付き添い、休息を取らない、他家族との交代を拒む
自分の苦痛を患者に見せまいとする	意識的な感情の抑制で支持関係を守る (Dong)	病室では明るく、廊下で崩れる

10-3. 相互作用モデルの適用と限界

- コーピングは直線的ではなく**動的なプロセス**であることが示された。ICUせん妄は人と環境のストレスフルな相互作用を構成し、患者と家族の双方に継続的な評価と再評価を引き起こす。これは Folkman (1997) の「一次的なコーピング努力が不十分であるときに意味基盤型コーピングが立ち現れる」という概念化と一致する。
- Folkman と Lazarus (1988) と一致して、**コーピングと情動体験は双方向の関係**で動いていた。意味づけは患者の失見当識と不安の低減に寄与し、社会的つながりを求めることは情動状態を肯定的に変化させた。
- せん妄による認知的制約にもかかわらず、患者は肯定的再評価・アイデンティティの回復・スピリチュアルな信念を含む意味基盤型戦略を示した。家族も正常化とアイデンティティ再構築という意味基盤型プロセスに関わった。
- **しかし著者らは重要な理論的留保を置いている。せん妄に特徴的な急性の認知障害を考えると、患者はモデルが概念化するような熟慮的な評価プロセスを完全には行えなかった可能性がある。**これが、認知的に障害がなく意識的・目標志向的なコーピングに関与できる家族介護者に比べて、患者側のコーピング戦略のエビデンス密度が低かったことを部分的に説明するかもしれない。それでも患者が意味基盤型を含む能動的コーピングを示したことは、**意識障害の状態でもコーピング能力は完全には停止しておらず、一部の戦略は反応的に、あるいは熟慮的認知処理の閾値の下で立ち現れうる**ことを示唆する。認知能力が回復する ICU 後の文脈での検証が必要とされる。
- モデルで説明しきれない行動もある。Folkman (1997) の拡張モデルに明示的に含まれるスピリチュアルな信念以外に、**占い・民間療法・伝統医療**といった文化的に埋め込まれた戦略は**モデルの射程を超える**。臨床実践でコーピングを評価し支援する際に文化的背景を考慮する必要性を裏づける所見。

10-4. 臨床的含意と患者・家族中心のケア(PFCC)

- 家族が能動的な主要対処資源であるという所見は、SCCM の **ABCDEF バンドル**(A: 痛みの評価・予防・管理／B: 自覚覚醒トライアルと自覚呼吸トライアルの両方／C: 鎮痛と鎮静の選択／D: せん妄の評価・予防・管理／E: 早期離床と運動／F: 家族の関与とエンパワメント)における家族参加の位置づけと一致する。最も新しく追加された「F」がこの役割を公式に認めている。
- 非薬物的介入の中で、**家族の関与と認知的運動はせん妄発症リスクを低下させることが示されている**。家族介護者が存在を通じて実施するせん妄介入は、見当識・アイデンティティ・社会的つながりを提供することで患者の転帰に良い効果を持つとされる。
- 家族参加は患者だけでなく家族自身にも利益をもたらす。せん妄患者の家族介護者は不安・うつ・PTSD という有意な心理的負担を負いやすいが、**ケアプロセスへの能動的関与はこれらの有害な心理的影響の最も有効な予防のひとつ**であることが示されている。家族参加は双方向の利益をもたらし、SCCM の家族中心ケアガイドラインの原則と一致する。
- 近年、**デジタルコミュニケーションツール**が対面の存在を補完する対処資源として家族の関与を促進することが示されている(本論文の第一著者らによる別の MMSR)。
- 具体的な介入の方向づけ:

対象	支えるべきコーピング	具体的な打ち手
患者	意味づけ(sense-making)	医療者による定期的でわかりやすい説明、ICU日記の活用(せん妄中・せん妄後の認知的再見当識の支援)
患者	統制感	音楽選択や環境の好みなど、小さな自律的決定を可能にする
家族	再見当識づけの実行	簡単なチェックリストや短い教育セッションによる構造化された関与
家族	自己の心理的負担	家族介護者向け心理支援をICUのケアプロトコルに統合する
両者	ICU後の継続	コーピングはICU滞在を越えて続くため、PICS・PICS-F に対応する心理社会的支援の連続性を介入開発で考慮する

11. 限界(著者らの記載・全7点)

- 1 **定量エビデンスがゼロ**。MMSR として設計したが適格な定量研究は1本もなく、知見の統計的一般化ができない。これはICUせん妄のコーピングに関する定量エビデンスの現在の不在を反映する。灰色文献を

系統的に検索していないため、定量データの不在には**出版バイアス**が部分的に関与する可能性がある。MMSR の枠組みを維持したのは、探索に先立って MMSR として前向き登録されていたためで、定量エビデンスの不在は事後のデザイン変更ではなくレビューの所見であるという立場。同様に MMAT を選んだのも事前登録プロトコルとの一貫性のためだが、**質的研究専用のチェックリストのほうが感度が高かった可能性がある**ことを著者ら自身が認めている。

- ② **1999～2025年という26年の幅**。ICU実践が大きく変化した期間にまたがるため、研究間の比較可能性が制限される。より現代的なエビデンスが必要。
- ③ **コーピングが一次アウトカムだったのは1本のみ**。Zhang ら(2025)だけがコーピング戦略を明示的に名づけられたテーマとして扱ったが、それも先験的な理論枠組みなしの分析。同定された戦略の深さと特異性が制限される。
- ④ **理論枠組みの後付け適用**。相互作用モデルを、もともとその理論的基盤を採用していない研究に分析枠組みとして当てた。同定されたコーピングのカテゴリは、データから独立に立ち現れたのではなく**モデルの構造を反映している可能性がある**。将来の研究では帰納的アプローチが望まれる。
- ⑤ **地理的分布が不十分**。異文化的視点を代表するには足りず、**低・中所得国からの研究はゼロ**。文化的に感受性の高い測定尺度と多様なサンプルが必要。
- ⑥ **成人ICU限定**。小児・新生児の設定は除外されたが、これらの文脈では家族の関与がむしろより中心的である可能性が高い。
- ⑦ **ICU入院期間に限定**。コーピングは退院後により広く展開しうる。PICS・PICS-F を包含する縦断研究が必要。

将来研究の提言: CISS(Coping Inventory for Stressful Situations) や Brief-COPE(Brief Coping Orientation to Problems Experienced) といった検証済みの尺度を用いた定量研究デザイン、および ICU後のコーピングにおける PICS・PICS-F アウトカムを捉える縦断的アプローチ。同定されたコーピング戦略は、せん妄ケアにおける患者・家族向けの標的化された心理社会的介入の開発に活かされるべきである。

12. 結論(著者ら)

Lazarus と Folkman の理論枠組みを適用すると、患者は — せん妄による認知的制約にもかかわらず — 家族とともにICUせん妄に対する**能動的な対処主体**として立ち現れ、臨床実践において両方の視点に取り組む必要性が浮かび上がる。同定されたコーピング戦略は、再見当識活動への構造化された家族関与とICU後回復期への心理社会的支援の連続性を含み、患者・家族中心でコーピングを踏まえた介入を開発する基盤となる。今後は、ICU後のコーピングと文化的多様性を含み定量研究が必要。より広く言えば、**患者と家族を能動的な**

対処主体として認識することは、ICUせん妄における心理社会的支援の設計と提供のあり方に直接の含意を持つ概念的な方向転換である。

13. 批判的吟味(JCでの論点)

△ 注意

この論文で最も注意すべき3点

- 1 これは「コーピングの研究」の統合ではなく、「コーピングについて偶然語られた部分」の統合である。10本中9本でコーピングは二次的・偶発的所見だった。つまり著者らは、別の目的(せん妄体験の記述、家族のニーズの探索など)で集められた語りから、コーピングに見える発言を後から抜き出して分類している。この構造上、「どの戦略が多かったか」の頻度は、実際の使用頻度ではなく元研究の関心の分布を反映している可能性が高い。「家族の情緒的存在が最も一貫していた」は、「家族の情緒的存在について最もよく質問された」の裏返しかもしれない。
- 2 理論枠組みの後付け適用による循環論法のリスク。著者ら自身が限界4として認めているとおり、Lazarus & Folkman の3分類を先に置いてから語りを振り分けているため、3分類すべてが埋まるのは半ば必然。「患者は3型すべてを示した」という所見は、データの発見というより分類作業の完了に近い。実際、患者の意味基盤型を支える証拠は Granberg(1999)と Menza(2024)の2本のみで、しかも Menza は音楽研究という特殊な文脈。
- 3 エビデンスの厚みが著しく不均一。「4研究で同定」(患者の意味づけ)から「1研究のみ」(スピリチュアル、文化的コーピング、ビデオ通話面会)まで幅がある。統合の文章はこの差を丁寧に書き分けているが、要約や結論では均されてしまう。読むときは必ず「何本の研究に支えられているか」を確認する必要がある。

その他の論点

- MMAT の質評価がほぼ満点なのは、逆に評価の識別力を疑わせる。10研究のうち8本が5基準すべてY、残り2本もCTが1つずつで、Nはゼロ。1999年の研究から2025年の研究まで質が均一に高いというのは直感に反する。著者ら自身が「MMATは質的研究専用のチェックリストより感度が低かったかもしれない」と認めており、**実質的に質評価は選別として機能していない**。COREQやCASP、あるいはGRADE-CERQualによる信頼性評価を併用していれば、統合知見ごとの確信度を示せたはずで、これは本レビューの明確な欠落。
- JBI メタアグリゲーションを名乗りながら、統合知見(synthesized findings)が明示的に番号づけされていない。JBIの標準的なアウトプットは「知見 → カテゴリ → 統合知見」を表で示し、ConQualによる

信頼性評価を付す形。本論文は叙述的にまとめており、どの記述が「知見」でどれが「カテゴリ」なのかの追跡ができない。再現性の観点では弱い。

- **サンプルサイズ「6～77名」の77は Darbyshire の患者40+家族37の合計であり、単一の質的研究のサンプルとしては極めて大きい。**これはアーカイブ面接の二次解析(もともと別の目的で集められたデータ)であり、しかも MMAT でデータ収集法が CT 判定された研究。統合における重みづけがされていないため、この1本の影響が大きくなっている可能性がある。
- **中国からの3本がすべて2024～2025年の新しい研究で、いずれも ICU退室後の面接である点。**せん妄「中」のコーピングを問うているのに、データの多くは退室後1週間～1か月後の回想。想起バイアスと、回復後の語り直し(narrative reconstruction)の影響は避けられない。ICU滞在中にデータを取ったのは Smithburger、Bohart、Menza(一部)のみ。
- **「患者は熟慮的評価ができない可能性がある」という留保は理論的に誠実だが、それを認めるとレビューの前提が揺らぐ。**患者側の「コーピング」の多くは、実際には回復後に本人が自分の行動を意味づけ直した産物である可能性がある。著者らはこれを「反応的・関下に立ち現れる」と表現して救済しているが、これは検証不能な主張。JC では「では患者側の所見をどこまで臨床に使ってよいか」を議論すべき。
- **臨床的含意のセクションが、レビューの所見よりも既存文献(ABCDEF バンドル、SCCM ガイドライン、家族関与のエビデンス)に依存している。**「家族関与がせん妄を減らす」「家族参加が家族のPTSDを防ぐ」はいずれも本レビューが示した所見ではなく、引用による裏づけ。本レビュー自体は効果を一切検証していないことを見失わないこと。
- **除外基準で「せん妄予防のみを扱う研究」を外したのは妥当だが、結果として非薬物的せん妄予防バンドルの質的評価研究が落ちている可能性がある。**家族参加型の予防プログラム(HELP など)の質的研究は、まさに家族のコーピングを扱っているはず。検索語に 'family involvement'、'nonpharmacological' が入っていない点も、感度への懸念。
- **低・中所得国がゼロという限界は、文化的コーピングの所見の一般化を強く制約する。**台湾1本から「文化的特異性」を語るのは踏み込みすぎで、著者らも「限られたエビデンス」と留保している。日本のICUに当てはめる際も、この1本を根拠にはできない。日本での質的研究が必要な領域。
- **改訂時の英文校正に ChatGPT-5.5 を使ったと明記している点は評価すべき透明性。**内容の責任は著者にあると明言しており、現在の学術出版のAI開示規範に沿っている。

14. 主要な引用文献一覧

#	内容	著者・雑誌・年
2	成人ICUにおけるせん妄サブタイプの発生率と有病率(31～80%の根拠)	Krewulak KD, et al. Crit Care Med. 2018;46(12):2029-35(系統的レビュー・メタ解析)
3	COVID-19重症患者のせん妄有病率 54.9%(14か国多施設コホート・COVID-D)	Pun BT, et al. Lancet Respir Med. 2021;9(3):239-250
7	患者・家族・看護スタッフに共通する3つの負担次元(症状・情緒・状況)	Schmitt EM, et al. 2019
18	患者と家族が「情緒的苦痛」をせん妄の最重要アウトカムとして100項目中1位に挙げた	優先順位づけ研究
19	ストレス・コーピングの相互作用モデル(本レビューの理論基盤)	Lazarus RS, Folkman S. Stress, Appraisal and Coping. 1984
20	コーピングと情動体験の双方向性	Folkman S, Lazarus RS. 1988
21	意味基盤型コーピングを含む改訂モデル (Figure 2 の原型)	Folkman S. 1997
25	ICUせん妄に伴う患者・家族の苦痛体験(情緒・認知・身体・関係)の既存統合	質的統合
28	MMAT(Mixed-Methods Appraisal Tool) 2018年版	Hong QN, et al.
29	JBI 収束統合アプローチとメタアグリゲーションの方法論	JBI マニュアル
40	ABCDEF バンドルの実施割合と転帰の用量反応関係(15,226例)	Pun BT, et al. Crit Care Med. 2019;47(1):3-14(ICU Liberation Collaborative)
41	せん妄の予防・治療介入のアンブレラレビュー(家族関与と認知的運動が発症リスクを下げる)	Veronese N, et al. Ageing Res Rev. 2024;97:102313
42	ICUにおけるせん妄予防での家族の役割(スコアリングレビュー)	Pabón-Martínez BA, et al. Enferm Intensiva. 2022;33(1):33-43

#	内容	著者・雑誌・年
43	SCCM 成人ICU家族中心ケアガイドライン 2024	Hwang DY, et al. Crit Care Med. 2025;53(2):e465-e482
44	成人ICUにおけるデジタルコミュニケーションツールの効果(本論文著者らの別 MMSR)	Oh E, et al. Crit Care. 2026;30(1):122
45	せん妄患者へのICU日記の使用(ドイツの看護の視点)	Nydahl P, Deffner T. Crit Care Nurs Clin North Am. 2021;33(1):37-46
46	Brief-COPE(将来の定量研究で推奨される尺度)	Carver CS. Int J Behav Med. 1997;4(1):92-100
47	CISS(Coping Inventory for Stressful Situations)	Endler NS, Parker JDA. Multi-Health Systems, 1990

採用された10研究: Granberg ら 1999(スウェーデン)／Whitehorne ら 2015(カナダ)／Darbyshire ら 2016(英国)／Smithburger ら 2017(米国)／Bohart ら 2019(デンマーク)／Huang ら 2022(台湾)／Ma ら 2024(中国)／Menza ら 2024(米国)／Dong ら 2025(中国)／Zhang ら 2025(中国)

✓ Take home message

TAKE HOME

結論 ICUせん妄の最中でも、患者は意味づけ・人とのつながり・小さな自律で能動的に対処しており、家族はその最大の対処資源であると同時に自分自身の苦痛も抱えている。**明日から変えるべきは、面会を「家族の権利」ではなく「せん妄ケアの介入」として位置づけ直し、家族に「そばにいて手に触れる・日付と場所を繰り返し伝える・家から馴染みの物を持ってくる・訂正はしない」の4点を書いたカードを渡すこと。**費用ゼロで今日から始められ、患者の見当識と家族自身の PICS-F の両方に効く可能性がある。

ただし**この論文は効果を一切検証していない**。10本中9本でコーピングは偶発的所見であり、理論枠組みは後付けで、定量エビデンスはゼロ。**「家族関与がせん妄を減らす」の根拠はこの論文ではなく引用文献の側にある**ことを混同しないこと。本論文の真価は、**患者と家族を「せん妄の被害者」から「能動的な対処主体」へと見方を変える概念的転換**にあり、そこにこそ Hotel ICU が向かうべき方向がある。

本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文(上記DOI)をご確認ください。原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません(本文の「図の解説」を参照)。作成: Claude Code(聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。